

Elektronisch Cliënten Dossier Arkin

Naam: Klootwijk, T

Clientnummer: 822577

Dossiernummer I70227739: 06-01-2022 t/m heden

Datum afschrift : 10-08-2026

Hierbij ontvangt u een kopie van de dossiergegevens bij Stichting Arkin waar u in behandeling bent, of bent geweest. Het dossier bevat medisch gevoelige gegevens, wij verzoeken u hier zorgvuldig mee om te gaan.

Inhoud:

0001-Algemeen-beloop

0002-App-Beloop

0003-Beloop-Klinisch-Doelgericht-Rapporteren

0004-Decursus-beloop

0005-Groepsrapportage-Indirect

Algemeen beloop

Koenders, Jitske (GZ-psycholoog) 07-08-2026 11:09:51

snelkeuze

omschrijving

datum

07/08/2026

verslag

- Dossier van afgelopen 2 weken aangevraagd op USB-stick via de servicedesk
- Signaleringsplan voorbereid om (zoals eerder al met clt besproken) te bespreken volgende week, hiervoor alle bestaande signaleringsplannen samengevoegd in 1 document om samen te evalueren

VPK: Nachtdienst

01 Debby Luiting (Verpleegkundige) 07-08-2026 07:09:01

snelkeuze

Nachtdienst

omschrijving

Nachtdienst

datum

07/08/2026

verslag

Dhr verbleef gedurende nacht op zijn kamer en geen contact gehad met dhr.
Kloof Varida

VPK: Nachtdienst

01 Debby Luiting (Verpleegkundige) 03-08-2026 07:57:47

snelkeuze

Nachtdienst

omschrijving

Nachtdienst

datum

03/08/2026

verslag

Dhr verbleef gedurende nacht op zijn kamer en geen contact gehad met dhr.
kloof Varida

VPK: Nachtdienst

01 Debby Luiting (Verpleegkundige) 02-08-2026 07:25:03

snelkeuze

Nachtdienst

omschrijving

Nachtdienst

datum

02/08/2026

verslag

Dhr verbleef gedurende nacht op zijn kamer en geen contact gehad met dhr.
kloof Varida

VPK: Nachtdienst

01 Debby Luiting (Verpleegkundige) 01-08-2026 07:18:48

snelkeuze
Nachtdienst

omschrijving
Nachtdienst

datum
01/08/2026

verslag
Dhr verbleef gedurende nacht op zijn kamer en geen contact gehad met dhr.
kloof Varida

VPK: Nachtdienst

Aslami, Ahmad (Clientondersteuner) 30-07-2026 05:13:13

snelkeuze
Nachtdienst

omschrijving
Nachtdienst

datum
30/07/2026

verslag
Dhr verbleef gedurende nacht op zijn kamer en geen contact gehad met dhr.

VPK: Nachtdienst

Aslami, Ahmad (Clientondersteuner) 29-07-2026 05:57:28

snelkeuze
Nachtdienst

omschrijving
Nachtdienst

datum
29/07/2026

verslag
Dhr verbleef gedurende nacht op zijn kamer en geen contact geweest met dhr.

VPK: Nachtdienst

Aslami, Ahmad (Clientondersteuner) 28-07-2026 05:14:41

snelkeuze
Nachtdienst

omschrijving
Nachtdienst

datum
28/07/2026

verslag
Dhr verbleef gedurende nacht op zijn kamer en geen contact geweest met dhr.

VPK: Nachtdienst

Aslami, Ahmad (Clientondersteuner) 27-07-2026 06:05:08

snelkeuze
Nachtdienst

omschrijving
Nachtdienst

datum

27/07/2026

verslag

Dhr verbleef gedurende nacht op zijn kamer en geen contact geweest met dhr.

dagdienst flexer zondag

Raspe, Martijn (Verpleegkundig specialist GGZ) 02-08-2026 13:15:03

verslag

Rustige dienst, was gelijk als eerste voor de medicatie.

Loopt heel veel in uit en het gebouw. Verder weinig bijzonderheden.

Rapp jostha.

Dhr was goed in contact en in gesprek stelde goede vragen en gaf ook antwoorden, kwam niet verward/onsamenhangend, over in gesprek.

Beloop Klinisch Doelgericht Rapporteren

Ham, Ruud (Verpleegkundige) 07-08-2026 20:30:56

observatiepunten en doelen

1. Zijn er veranderingen in psychiatrische toestandsbeeld?
2. Hoe is dhr. in contact? Hoe is zijn stemming?
3. Hoe vult dhr zijn dag in? Is hij naar dagbesteding (ROADS Hoofddorp) geweest? Op woensdag? Hoeft geen OV-kaarten meegegeven te worden.
4. ADL/HDL op orde?
- ?
- ?
- ?
- ?

doelgerichte rapportage

Aanwezig bij koffiemoment. Adequaat in contact, weet het gesprek goed te volgen. Gaf aan eenmaal kort afgeleid te zijn, maar herstelde zich snel. In conversatie geeft hij aan bezig te zijn met zijn toekomst: wil van bewindvoering af, wil baan gaan zoeken, als RIBW niet snel levert wil hij wat gaan huren. Weet dat dat duur is, denkt genoeg te gaan verdienen om dat te kunnen betalen. Zijn betoog valt in zekere zin in termen van herstel uit te leggen, aan de andere kant is het uit te leggen als wat manifom gedrag. Hij reageert sneller op ideeën in de conversatie waarbij hij zichzelf hoger uit als gewend van hem. Op mijn vraag of hij nog iets ging doen reageerde hij vlot door te zeggen dat dat een goed idee was. Kwam zich nog geen 15 minuten later afmelden, ging met vriend Deniz de stad in. Zou appen als het later als 00.00 ging worden of elders zou gaan slapen (waar hij al maanden terug toestemming voor heeft om dat spontaan te kunnen beslissen).

algemeen beloop

Beloop Klinisch Doelgericht Rapporteren

Overman, Jostha (Verpleegkundige) 07-08-2026 16:06:45

observatiepunten en doelen

1. Zijn er veranderingen in psychiatrische toestandsbeeld?
2. Hoe is dhr. in contact? Hoe is zijn stemming?
3. Hoe vult dhr zijn dag in? Is hij naar dagbesteding (ROADS Hoofddorp) geweest? Op woensdag? Hoeft geen OV-kaarten meegegeven te worden.
4. ADL/HDL op orde?
- ?
- ?
- ?
- ?

doelgerichte rapportage

Geen verandering in psychische toestand beeld
Dhr geeft aan niets te merken van verhoging medicatie.
Is verder goed in contact, is geïntreseed in gezondheid van og,en ook in gesprek bij koffie moment
Is deze week naar lab geweest.

algemeen beloop

Moeder had iets voor dhr besteld die was bezorgd, en collega had pakket in ontvangst genomen maar dat was niet bekend. Dhr was dan opzoek naar pakket en raakte gestress. Uiteindelijk is pakket terecht gekomen.

Beloop Klinisch Doelgericht Rapporteren

Linger, Brandy (Groepsbegeleider) 06-08-2026 20:42:37

observatiepunten en doelen

1. Zijn er veranderingen in psychiatrische toestandsbeeld?
2. Hoe is dhr. in contact? Hoe is zijn stemming?
3. Hoe vult dhr zijn dag in? Is hij naar dagbesteding (ROADS Hoofddorp) geweest? Op woensdag? Hoeft geen OV-kaarten meegegeven te worden.
4. ADL/HDL op orde?
- ?
- ?
- ?

?

doelgerichte rapportage

Dhr. was aanwezig tijdens koffiemoment.

Dhr. vertelde dat hij vandaag gesprek gehad heeft met pso en moeder. Dhr. is hierna met moeder op stap geweest, samen hebben zij een patatje gegeten.

Dhr. gaf aan dat hij zijn Al abonnement wilt opzeggen, en zijn VR-bril te koop wilt zetten op marktplaats. Dhr. geeft aan dat hij op dit moment van beide geen gebruik maakt. Dhr. wilt zich minder op de digitale wereld focussen en zich bezig houden met andere zaken.

Dhr. is vriendelijk in contact, goed te volgen in gesprekken.

Dhr. ziet er verzorgd uit.

algemeen beloop

Beloop Klinisch Doelgericht Rapporteren

Benschop, Menno (Groepsbegeleider) 06-08-2026 09:50:16

observatiepunten en doelen

1. Zijn er veranderingen in psychiatrische toestandbeeld?

2. Hoe is dhr. in contact? Hoe is zijn stemming?

3. Hoe vult dhr zijn dag in? Is hij naar dagbesteding (ROADS Hoofddorp) geweest? Op woensdag? Hoeft geen OV-kaarten meegegeven te worden.

4. ADL/HDL op orde?

?

?

?

?

doelgerichte rapportage

dhr was rond 08:35 bij de meidcaiteruimte voor zijn medicatie. dhr heeft goed geslapen en gaf aan bij het koffie moment te zijn om 10:00 uur.

algemeen beloop

Beloop Klinisch Doelgericht Rapporteren

Zumbrink, Nanda (Verpleegkundige) 06-08-2026 05:34:54

observatiepunten en doelen

1. Zijn er veranderingen in psychiatrische toestandbeeld?

2. Hoe is dhr. in contact? Hoe is zijn stemming?

3. Hoe vult dhr zijn dag in? Is hij naar dagbesteding (ROADS Hoofddorp) geweest? Op woensdag? Hoeft geen OV-kaarten meegegeven te worden.

4. ADL/HDL op orde?

?

?

?

?

doelgerichte rapportage

algemeen beloop

Dhr. verbleef gedurende nacht op zijn kamer en geen contact gehad met dhr.

Beloop Klinisch Doelgericht Rapporteren

Helsloot, Rakinah (Ambulant verpleegkundige) 05-08-2026 20:50:12

observatiepunten en doelen

1. Zijn er veranderingen in psychiatrische toestandbeeld?

2. Hoe is dhr. in contact? Hoe is zijn stemming?

3. Hoe vult dhr zijn dag in? Is hij naar dagbesteding (ROADS Hoofddorp) geweest? Op woensdag? Hoeft geen OV-kaarten meegegeven te worden.

4. ADL/HDL op orde?

?

?

?

?

doelgerichte rapportage

1. Dhr. gaf aan moe te zijn van de dagbesteding en kwam hierdoor ook niet naar het koffie moment.
2. Dhr. was functioneel in contact en stemming was wat mat.
3. Dhr. is naar dagbesteding geweest, was hierna wel moe.

algemeen beloop

Beloop Klinisch Doelgericht Rapporteren

Linger, Brandy (Groepsbegeleider) 05-08-2026 13:37:37

observatiepunten en doelen

1. Zijn er veranderingen in psychiatrische toestandsbeeld?
2. Hoe is dhr. in contact? Hoe is zijn stemming?
3. Hoe vult dhr zijn dag in? Is hij naar dagbesteding (ROADS Hoofddorp) geweest? Op woensdag? Hoeft geen OV-kaarten meegegeven te worden.
4. ADL/HDL op orde?
- ?
- ?
- ?
- ?

doelgerichte rapportage

Dhr. gedurende dienst niet gezien, is naar DB.

algemeen beloop

Beloop Klinisch Doelgericht Rapporteren

Zumbrink, Nanda (Verpleegkundige) 04-08-2026 23:45:00

observatiepunten en doelen

1. Zijn er veranderingen in psychiatrische toestandsbeeld?
2. Hoe is dhr. in contact? Hoe is zijn stemming?
3. Hoe vult dhr zijn dag in? Is hij naar dagbesteding (ROADS Hoofddorp) geweest? Op woensdag? Hoeft geen OV-kaarten meegegeven te worden.
4. ADL/HDL op orde?
- ?
- ?
- ?
- ?

doelgerichte rapportage

algemeen beloop

Dhr. verbleef gedurende nacht op zijn kamer en geen contact gehad met dhr.

Beloop Klinisch Doelgericht Rapporteren

Ham, Ruud (Verpleegkundige) 04-08-2026 21:22:52

observatiepunten en doelen

1. Zijn er veranderingen in psychiatrische toestandsbeeld?
2. Hoe is dhr. in contact? Hoe is zijn stemming?
3. Hoe vult dhr zijn dag in? Is hij naar dagbesteding (ROADS Hoofddorp) geweest? Op woensdag? Hoeft geen OV-kaarten meegegeven te worden.
4. ADL/HDL op orde?
- ?
- ?
- ?
- ?

doelgerichte rapportage

Adequaat in contact bij koffiemoment. Een klein moment waargenomen waarbij zijn blik wegtrok en hij minder gefocust was op het gesprek. Dit duurde slechts enkele momenten. Zegt verder goed in zijn vel te zitten. Kijkt uit naar dagbesteding morgen.

algemeen beloop

Haalde zijn medicatie van morgen op i.v.m. dagbesteding.

Beloop Klinisch Doelgericht Rapporteren

Linger, Brandy (Groepsbegeleider) 04-08-2026 08:44:34

observatiepunten en doelen

1. Zijn er veranderingen in psychiatrische toestandsbeeld?
2. Hoe is dhr. in contact? Hoe is zijn stemming?
3. Hoe vult dhr zijn dag in? Is hij naar dagbesteding (ROADS Hoofddorp) geweest? Op woensdag? Hoeft geen OV-kaarten meegegeven te worden.
4. ADL/HDL op orde?
- ?
- ?
- ?
- ?

doelgerichte rapportage

Dhr. kwam in de ochtend voor zijn medicatie, kreeg deze volgens de deellijst. dhr. vertelde aan o.g dat zijn medicatie verhoogd is.
Dhr. herinnerd aan lab-bezoek, dhr. verwacht dat het gezien de tijd (08:35) druk zal zijn en wilt liever donderdag naar het lab. Dhr. gaf aan dit in zijn agenda te noteren.
Dhr. is vriendelijk gestemd, vraagt aan o.g hoe het met haar gaat.
Dhr. ziet er verzorgd uit.
Dhr. is naar het lab geweest.

algemeen beloop

Beloop Klinisch Doelgericht Rapporteren

Zumbrink, Nanda (Verpleegkundige) 04-08-2026 02:28:01

observatiepunten en doelen

1. Zijn er veranderingen in psychiatrische toestandsbeeld?
2. Hoe is dhr. in contact? Hoe is zijn stemming?
3. Hoe vult dhr zijn dag in? Is hij naar dagbesteding (ROADS Hoofddorp) geweest? Op woensdag? Hoeft geen OV-kaarten meegegeven te worden.
4. ADL/HDL op orde?
- ?
- ?
- ?
- ?

doelgerichte rapportage

algemeen beloop

Dhr. verbleef gedurende nacht op zijn kamer en geen contact gehad met dhr.

Beloop Klinisch Doelgericht Rapporteren

Ham, Ruud (Verpleegkundige) 03-08-2026 22:07:47

observatiepunten en doelen

1. Zijn er veranderingen in psychiatrische toestandsbeeld?
2. Hoe is dhr. in contact? Hoe is zijn stemming?
3. Hoe vult dhr zijn dag in? Is hij naar dagbesteding (ROADS Hoofddorp) geweest? Op woensdag? Hoeft geen OV-kaarten meegegeven te worden.
4. ADL/HDL op orde?
- ?
- ?
- ?
- ?

doelgerichte rapportage

Aanwezig bij koffiemoment. Is adequaat in contact. Lijkt zich moeilijk te kunnen focussen op het gespreksonderwerp. Kijkt veel om zich heen. Aandacht is wel goed te trekken.

algemeen beloop

Beloop Klinisch Doelgericht Rapporteren

Overman, Jostha (Verpleegkundige) 03-08-2026 16:23:15

observatiepunten en doelen

1. Zijn er veranderingen in psychiatrische toestandsbeeld?

2. Hoe is dhr. in contact? Hoe is zijn stemming?
3. Hoe vult dhr zijn dag in? Is hij naar dagbesteding (ROADS Hoofddorp) geweest? Op woensdag? Hoeft geen OV-kaarten meegegeven te worden.
4. ADL/HDL op orde?
- ?
- ?
- ?
- ?

doelgerichte rapportage

algemeen beloop

Dhr heeft medicatie gehad. Heeft gesprek met PSO en PSA zie rapp hierover.
Dhr is vandaag gestart met verhoging van zijn medicatie aripiprazol van 2.5mg naar 5mg. heeft deze al gehad.
Morgen naar lab. dhr is hiervan op de hoogte

Beloop Klinisch Doelgericht Rapporteren

Lange, Jennifer de (Clientondersteuner) 02-08-2026 21:40:53

observatiepunten en doelen

1. Zijn er veranderingen in psychiatrische toestandsbeeld?
2. Hoe is dhr. in contact? Hoe is zijn stemming?
3. Hoe vult dhr zijn dag in? Is hij naar dagbesteding (ROADS Hoofddorp) geweest? Op woensdag? Hoeft geen OV-kaarten meegegeven te worden.
4. ADL/HDL op orde?
- ?
- ?
- ?
- ?

doelgerichte rapportage

- 1) Clt. lijkt af en toe wat afwezig tijdens het koffiemoment, houdt de klok veelvuldig in de gaten. Dhr. heeft af en toe een bedenkelijke blik.
- 2) Dhr. is vriendelijk in contact
- 3) Gedurende dienst gaat dhr. veel zijn eigen gang, is bezig met programmeren of gaat veel naarbuiten voor een wandeling.
- 4) Beiden in orde.

algemeen beloop

Beloop Klinisch Doelgericht Rapporteren

Sieben, Eline (Verpleegkundige) 01-08-2026 22:01:32

observatiepunten en doelen

1. Zijn er veranderingen in psychiatrische toestandsbeeld?
2. Hoe is dhr. in contact? Hoe is zijn stemming?
3. Hoe vult dhr zijn dag in? Is hij naar dagbesteding (ROADS Hoofddorp) geweest? Op woensdag? Hoeft geen OV-kaarten meegegeven te worden.
4. ADL/HDL op orde?
- ?
- ?
- ?
- ?

doelgerichte rapportage

1. dhr keek tijdens het koffiemoment een paar keer naar wat leek het plafond? Ook vertelde dhr 2x hetzelfde verhaal over zijn podcast. OG gaat hier morgen op letten. Og kan dhr wel in die paar keer weer terughalen naar het huidige gesprek. Verder vroeg dhr hoe het ging met OG en het familieweekend dat zei organiseert. Hierin was dhr weer goed te volgen. Og let hier morgen op en gaat anders met dhr morgen in gesprek hierover.
2. Wisselend in contact (lijkt af en toe met gedachte ergens anders). Stemming is goed.
3. dhr wandelt veel en luistert podcast. Is met een game bezig met fantasie.
4. beide op orde.

algemeen beloop

Beloop Klinisch Doelgericht Rapporteren

Overman, Jostha (Verpleegkundige) 01-08-2026 14:51:49

observatiepunten en doelen

1. Zijn er veranderingen in psychiatrische toestandsbeeld?
2. Hoe is dhr. in contact? Hoe is zijn stemming?
3. Hoe vult dhr zijn dag in? Is hij naar dagbesteding (ROADS Hoofddorp) geweest? Op woensdag? Hoeft geen OV-kaarten meegegeven te worden.
4. ADL/HDL op orde?
- ?
- ?
- ?
- ?

doelgerichte rapportage

Dhr is goed in contact geen verandering in psychiatrisch toestandbeeld waargenomen. (geen rare onsamenhangende gesprek/verhalen)
Stemming is normaal
Geen dagplanning aangegeven.
ADL in orde.

algemeen beloop

Dhr gezien voor zijn ochtend medicatie nam de in.

Beloop Klinisch Doelgericht Rapporteren

Mouw, Kiki (Groepsbegeleider) 31-07-2026 20:57:15

observatiepunten en doelen

1. Zijn er veranderingen in psychiatrische toestandsbeeld?
2. Hoe is dhr. in contact? Hoe is zijn stemming?
3. Hoe vult dhr zijn dag in? Is hij naar dagbesteding (ROADS Hoofddorp) geweest? Op woensdag? Hoeft geen OV-kaarten meegegeven te worden.
4. ADL/HDL op orde?
- ?
- ?
- ?
- ?

doelgerichte rapportage

1. Dhr is aanwezig bij koffiemoment, dhr is dan redelijk te volgen. Zijn input is veelal filosofisch van aard. Hij kan zijn aandacht goed bij het groepsgesprek houden, al maakt hij af en toe een wending die wat lastig te volgen is.
2. Dhr is vriendelijk in contact en goed gestemd.
4. ADL op orde.

algemeen beloop

Beloop Klinisch Doelgericht Rapporteren

Overman, Jostha (Verpleegkundige) 31-07-2026 14:21:29

observatiepunten en doelen

1. Zijn er veranderingen in psychiatrische toestandsbeeld?
2. Hoe is dhr. in contact? Hoe is zijn stemming?
3. Hoe vult dhr zijn dag in? Is hij naar dagbesteding (ROADS Hoofddorp) geweest? Op woensdag? Hoeft geen OV-kaarten meegegeven te worden.
4. ADL/HDL op orde?
- ?
- ?
- ?
- ?

doelgerichte rapportage

algemeen beloop

Dhr gezien voor medicatie, nam die in was later bij koffie moment aanwezig.
Dhr info brief gegeven over algemene huisregels van Arkin.

Beloop Klinisch Doelgericht Rapporteren

Linger, Brandy (Groepsbegeleider) 30-07-2026 20:46:29

observatiepunten en doelen

1. Zijn er veranderingen in psychiatrische toestandsbeeld?
2. Hoe is dhr. in contact? Hoe is zijn stemming?
3. Hoe vult dhr zijn dag in? Is hij naar dagbesteding (ROADS Hoofddorp) geweest? Op woensdag? Hoeft geen OV-kaarten meegegeven te worden.
4. ADL/HDL op orde?
- ?
- ?
- ?
- ?

doelgerichte rapportage

Dhr. was aanwezig tijdens het koffiemoment. Tijdens gesprekken was dhr. af en toe moeilijk te volgen. Daarnaast werd geobserveerd dat dhr. meerdere keren gedurende enige tijd naar een vast punt keek en niet direct reageerde op het gesprek. Na verloop van tijd pakte dhr. het gesprek weer op, soms volgde dhr. dan zelf het groepsgesprek niet meer en vroeg hij aan medebewoner waar het over ging. Dhr. op een willekeurig moment de vraag: "Hebben jullie aandelen?" Een medebewoner reageerde hierop met de vraag: "Investeer jij ergens in?" Dhr. antwoordde daarop: "Ik investeer in mijn toekomst." En legt uit dat hij producten heeft bedacht die veel geld kunnen opleveren. Dhr. is goed gestemd en verder vriendelijk in contact. Dhr. ziet er verzorgd uit, geen zicht gehad op HDL.

algemeen beloop

Beloop Klinisch Doelgericht Rapporteren

Benschop, Menno (Groepsbegeleider) 30-07-2026 11:41:55

observatiepunten en doelen

1. Zijn er veranderingen in psychiatrische toestandsbeeld?
2. Hoe is dhr. in contact? Hoe is zijn stemming?
3. Hoe vult dhr zijn dag in? Is hij naar dagbesteding (ROADS Hoofddorp) geweest? Op woensdag? Hoeft geen OV-kaarten meegegeven te worden.
4. ADL/HDL op orde?
- ?
- ?
- ?
- ?

doelgerichte rapportage

geen veranderingen waargenomen
dhr is vriendelijk in contact, komt medicatie halen en is daarna naar buiten gegaan.
ADL is op orde

algemeen beloop

Beloop Klinisch Doelgericht Rapporteren

Mouw, Kiki (Groepsbegeleider) 29-07-2026 21:16:03

observatiepunten en doelen

1. Zijn er veranderingen in psychiatrische toestandsbeeld?
2. Hoe is dhr. in contact? Hoe is zijn stemming?
3. Hoe vult dhr zijn dag in? Is hij naar dagbesteding (ROADS Hoofddorp) geweest? Op woensdag? Hoeft geen OV-kaarten meegegeven te worden.
4. ADL/HDL op orde?
- ?
- ?
- ?
- ?

doelgerichte rapportage

1. Dhr is redelijk te volgen in gesprek, zegt een paar keer iets over de invloed van zijn uitvindingen. Dhr grapt zelf dat hij geen Messiah-complex heeft, komt adequaat over.
2. Dhr is vriendelijk in contact, prima gestemd.
3. Dhr is naar dagbesteding geweest, vertelt dat hij bezig is met een augmented reality met een panda omdat hij even wat minder met technologie en meer met natuur bezig wil zijn.
4. ADL op orde

algemeen beloop

Beloop Klinisch Doelgericht Rapporteren

Zumbrink, Nanda (Verpleegkundige) 29-07-2026 14:37:39

observatiepunten en doelen

1. Zijn er veranderingen in psychiatrische toestandsbeeld?
2. Hoe is dhr. in contact? Hoe is zijn stemming?
3. Hoe vult dhr zijn dag in? Is hij naar dagbesteding (ROADS Hoofddorp) geweest? Op woensdag? Hoeft geen OV-kaarten meegegeven te worden.
4. ADL/HDL op orde?
- ?
- ?
- ?
- ?

doelgerichte rapportage

Dhr. niet gezien vanmorgen. Dhr. is naar dagbesteding vandaag.

algemeen beloop

Beloop Klinisch Doelgericht Rapporteren

Lange, Jennifer de (Clientondersteuner) 28-07-2026 21:44:43

observatiepunten en doelen

1. Zijn er veranderingen in psychiatrische toestandsbeeld?
2. Hoe is dhr. in contact? Hoe is zijn stemming?
3. Hoe vult dhr zijn dag in? Is hij naar dagbesteding (ROADS Hoofddorp) geweest? Op woensdag? Hoeft geen OV-kaarten meegegeven te worden.
4. ADL/HDL op orde?
- ?
- ?
- ?
- ?

doelgerichte rapportage

- 1) Dhr. lijkt in wat betere doen vergeleken het weekend, lijkt een wat heldere blik te hebben. Geen onsamenvattende verhalen gehoord.
- 2) Clt. is vriendelijk in contact, komt wat meer ontspannen over.
- 3) Dhr. Is veelal buiten geweest, wandelt veel. Dhr. sloot bij het koffiemoment aan, is gezellig in de omgang.
- 4) Geen zicht op kamer gehad, dhr. zelf ziet er verzorgd uit.

algemeen beloop

Dhr. kreeg zijn medicatie voor morgen mee i.v.m DB.

Dhr. heeft een kleurtje in zijn gezicht, wel zijn zijn armen door de zon verbrand. Aangeraden om morgen gebruik te maken van de zonnebrand op kantoor. Nog aftersun voor dhr. gezocht, deze niet kunnen vinden.

Beloop Klinisch Doelgericht Rapporteren

Leysner, Mireille (Groepsbegeleider) 28-07-2026 13:42:25

observatiepunten en doelen

1. Zijn er veranderingen in psychiatrische toestandsbeeld?
2. Hoe is dhr. in contact? Hoe is zijn stemming?
3. Hoe vult dhr zijn dag in? Is hij naar dagbesteding (ROADS Hoofddorp) geweest? Op woensdag? Hoeft geen OV-kaarten meegegeven te worden.
4. ADL/HDL op orde?
- ?
- ?
- ?
- ?

doelgerichte rapportage

1. Geen psychotische kenmerken waargenomen
2. Vriendelijk en open in contact. Dhr zegt zich steeds beter te voelen, krijgt hierover een compliment van og. Dit wordt door dhr gewaardeerd.
3. Dhr geniet van het weer , maakt flinke wandelingen en zegt hiervan te genieten. Is van plan

morgen een pet te gaan kopen ivm de verwachte warmte.
4. Komt op tijd voor medicatie, dhr ziet er vrsorgd uit. Kamer is niet gecheckt.

algemeen beloop

Beloop Klinisch Doelgericht Rapporteren

Ham, Ruud (Verpleegkundige) 27-07-2026 21:08:21

observatiepunten en doelen

1. Zijn er veranderingen in psychiatrische toestandsbeeld?
2. Hoe is dhr. in contact? Hoe is zijn stemming?
3. Hoe vult dhr zijn dag in? Is hij naar dagbesteding (ROADS Hoofddorp) geweest? Op woensdag? Hoeft geen OV-kaarten meegegeven te worden.
4. ADL/HDL op orde?
- ?
- ?
- ?
- ?

doelgerichte rapportage

Aanwezig bij koffiemoment, adequaat en gefocust op het gesprek als vanouds.

algemeen beloop

Beloop Klinisch Doelgericht Rapporteren

Linger, Brandy (Groepsbegeleider) 27-07-2026 09:33:32

observatiepunten en doelen

1. Zijn er veranderingen in psychiatrische toestandsbeeld?
2. Hoe is dhr. in contact? Hoe is zijn stemming?
3. Hoe vult dhr zijn dag in? Is hij naar dagbesteding (ROADS Hoofddorp) geweest? Op woensdag? Hoeft geen OV-kaarten meegegeven te worden.
4. ADL/HDL op orde?
- ?
- ?
- ?
- ?

doelgerichte rapportage

Dhr. kwam in de ochtend voor zijn medicatie, kreeg deze volgens de deellijst.
Dhr. komt ontspannen over. Vertelt over zijn weekend en vraagt aan o.g. hoe haar weekend was.
Dhr. geeft aan dat hij vandaag podcast gaat luisteren en met projecten bezig zal zijn.

algemeen beloop

Toevoeging Patricia:
Dhr. is bij koffiemoment aangesloten. Uitgebreid gesproken over verschillende onderwerpen. Zoals, nieuws, videogames, AI en boeken. Dhr. toont ook zelf initiatief in het gesprek door vragen te stellen aan o.g. iets uitgebreider gesproken over videogame maken, waar Dhr. mee bezig is. Laat het ook enthousiast zien hoe het er nu uitziet. Vertelt het technische gedeelte wel met enig gemak gaat, maar het verhaal van het spel nog lastig vindt. Geeft aan door het gesprek weer wat aangewakkerd is om aan de slag te gaan ermee. Ook gehad over balans tussen nieuws en ontspanning, geeft aan hier alert op te zijn en het negatieve nieuws niet te zwaar te laten wegen. Bedankt voor het gesprek en het enthousiasme van o.g. Dat dit ook aanstekelijk werkt.

Beloop Klinisch Doelgericht Rapporteren

Ham, Ruud (Verpleegkundige) 26-07-2026 20:48:52

observatiepunten en doelen

1. Zijn er veranderingen in psychiatrische toestandsbeeld?
2. Hoe is dhr. in contact? Hoe is zijn stemming?
3. Hoe vult dhr zijn dag in? Is hij naar dagbesteding (ROADS Hoofddorp) geweest? Op woensdag? Hoeft geen OV-kaarten meegegeven te worden.
4. ADL/HDL op orde?
- ?
- ?
- ?
- ?

doelgerichte rapportage

Aanwezig bij koffiemoment. Adequaat in contact, komt wat afwezig over, lijkt met andere gedachten bezig te zijn

algemeen beloop

Beloop Klinisch Doelgericht Rapporteren

Sieben, Eline (Verpleegkundige) 26-07-2026 14:03:18

observatiepunten en doelen

1. Zijn er veranderingen in psychiatrische toestandsbeeld?
2. Hoe is dhr. in contact? Hoe is zijn stemming?
3. Hoe vult dhr zijn dag in? Is hij naar dagbesteding (ROADS Hoofddorp) geweest? Op woensdag? Hoeft geen OV-kaarten meegegeven te worden.
4. ADL/HDL op orde?
- ?
- ?
- ?
- ?

doelgerichte rapportage

1. geen bijzonderheden waargenomen.
2. prima in contact en stemming.
3. dhr wandelt buiten en luisterd podcast
4. adl op orde en kamer niet gezien.

algemeen beloop

Beloop Klinisch Doelgericht Rapporteren

Berri, Adil (Verpleegkundige) 26-07-2026 06:40:49

observatiepunten en doelen

1. Zijn er veranderingen in psychiatrische toestandsbeeld?
2. Hoe is dhr. in contact? Hoe is zijn stemming?
3. Hoe vult dhr zijn dag in? Is hij naar dagbesteding (ROADS Hoofddorp) geweest? Op woensdag? Hoeft geen OV-kaarten meegegeven te worden.
4. ADL/HDL op orde?
- ?
- ?
- ?
- ?

doelgerichte rapportage

algemeen beloop

Dhr verbleef gedurende de nacht op zijn appartement, geen contact met dhr gehad.

Beloop Klinisch Doelgericht Rapporteren

Ham, Ruud (Verpleegkundige) 25-07-2026 21:50:50

observatiepunten en doelen

1. Zijn er veranderingen in psychiatrische toestandsbeeld?
2. Hoe is dhr. in contact? Hoe is zijn stemming?
3. Hoe vult dhr zijn dag in? Is hij naar dagbesteding (ROADS Hoofddorp) geweest? Op woensdag? Hoeft geen OV-kaarten meegegeven te worden.
4. ADL/HDL op orde?
- ?
- ?
- ?
- ?

doelgerichte rapportage

Vriendelijk in contact. Informatief naar anderen. Lijkt in gesprek soms afgeleid, kijkt dan andere kant op voor korte tijd en lijkt zich dan even te moeten herorganiseren. Adequaat in contact, op zich goed te volgen in gesprek.. Vertelt op het eind van het gesprek met iets bezig te zijn waar de mensheid baat bij zal hebben als hij het publiceert. Lijkt niet concreter te willen worden in wat hij daarmee bedoeld.
Lijkt soms wat groetheidsideeen te hebben die hij in dezelve zin weer terugneemt of bagettelliseert.

algemeen beloop

Beloop Klinisch Doelgericht Rapporteren

Sieben, Eline (Verpleegkundige) 25-07-2026 11:18:13

observatiepunten en doelen

1. Zijn er veranderingen in psychiatrische toestandbeeld?
2. Hoe is dhr. in contact? Hoe is zijn stemming?
3. Hoe vult dhr zijn dag in? Is hij naar dagbesteding (ROADS Hoofddorp) geweest? Op woensdag? Hoeft geen OV-kaarten meegegeven te worden.
4. ADL/HDL op orde?
- ?
- ?
- ?
- ?

doelgerichte rapportage

Dhr heeft minder goed geslapen ivm uitgaan. Ging na de medicatie nog even bijslapen. Zou in de middag gaan wandelen.

algemeen beloop

Beloop Klinisch Doelgericht Rapporteren

Berri, Adil (Verpleegkundige) 25-07-2026 06:16:34

observatiepunten en doelen

1. Zijn er veranderingen in psychiatrische toestandbeeld?
2. Hoe is dhr. in contact? Hoe is zijn stemming?
3. Hoe vult dhr zijn dag in? Is hij naar dagbesteding (ROADS Hoofddorp) geweest? Op woensdag? Hoeft geen OV-kaarten meegegeven te worden.
4. ADL/HDL op orde?
- ?
- ?
- ?
- ?

doelgerichte rapportage

algemeen beloop

Dhr kwam rond 23:50 uur terug, ging rechtstreeks naar zijn appartement.
Dhr verbleef gedurende de nacht op zijn appartement, geen contact met dhr gehad.

Beloop Klinisch Doelgericht Rapporteren

Mouw, Kiki (Groepsbegeleider) 24-07-2026 20:47:43

observatiepunten en doelen

1. Zijn er veranderingen in psychiatrische toestandbeeld?
2. Hoe is dhr. in contact? Hoe is zijn stemming?
3. Hoe vult dhr zijn dag in? Is hij naar dagbesteding (ROADS Hoofddorp) geweest? Op woensdag? Hoeft geen OV-kaarten meegegeven te worden.
4. ADL/HDL op orde?
- ?
- ?
- ?
- ?

doelgerichte rapportage

Dhr is niet in huis bij cm 20u en 22u (is in de kroeg met vriend)

algemeen beloop

Beloop Klinisch Doelgericht Rapporteren

Lange, Jennifer de (Clientondersteuner) 24-07-2026 11:37:48

observatiepunten en doelen

1. Zijn er veranderingen in psychiatrische toestandbeeld?

2. Hoe is dhr. in contact? Hoe is zijn stemming?
3. Hoe vult dhr zijn dag in? Is hij naar dagbesteding (ROADS Hoofddorp) geweest? Op woensdag? Hooft geen OV-kaarten meegegeven te worden.
4. ADL/HDL op orde?
- ?
- ?
- ?
- ?

doelgerichte rapportage

Dhr. kwam vanmorgen uit zichzelf voor zijn ochtendgift. Clt. is vriendelijk in contact en spraakzaam bij het koffiemoment.

Clt. gaat gedurende dag zijn eigen gang, wat programmeren. Vanavond heeft dhr. met een vriend in de stad afgesproken, gaan naar de kroeg.

algemeen beloop**Beloop Klinisch Doelgericht Rapporteren**

Berri, Adil (Verpleegkundige) 24-07-2026 07:13:01

observatiepunten en doelen

1. Zijn er veranderingen in psychiatrische toestandsbeeld?
2. Hoe is dhr. in contact? Hoe is zijn stemming?
3. Hoe vult dhr zijn dag in? Is hij naar dagbesteding (ROADS Hoofddorp) geweest? Op woensdag? Hooft geen OV-kaarten meegegeven te worden.
4. ADL/HDL op orde?
- ?
- ?
- ?
- ?

doelgerichte rapportage**algemeen beloop**

Dhr verbleef gedurende de nacht op zijn appartement, geen contact met dhr gehad.

Beloop Klinisch Doelgericht Rapporteren

Mouw, Kiki (Groepsbegeleider) 23-07-2026 21:08:32

observatiepunten en doelen

1. Zijn er veranderingen in psychiatrische toestandsbeeld?
2. Hoe is dhr. in contact? Hoe is zijn stemming?
3. Hoe vult dhr zijn dag in? Is hij naar dagbesteding (ROADS Hoofddorp) geweest? Op woensdag? Hooft geen OV-kaarten meegegeven te worden.
4. ADL/HDL op orde?
- ?
- ?
- ?
- ?

doelgerichte rapportage

1. Naar OG's mening is Dhr lastiger te volgen in zijn verhalen. Dhr komt voornamelijk neer op dat mensen niet te vertrouwen zijn en benoemt een paar keer dat hij verantwoordelijk is voor wat er met zijn uitvindingen gedaan wordt. OG geeft aan dat zij dhr niet goed volgt, dat hij wat van de hak op de tak lijkt te gaan en dat og zich een beetje zorgen maakt (zoals afgesproken met dhr om hem direct aan te spreken bij dit soort vermoedens). Dhr wordt hier een beetje bozig van, gaat er tegenin, maar is ook daarin voor og lastig te volgen. Uiteindelijk zegt hij dat hij ook gewoon stil kan zijn, en dat Jitske (pso) dan morgen bij hem voor z'n deur zou staan, net zoals vorige week. Daarna keek hij OG nauwelijks meer aan en het enige waar hij in het gesprek van de anderen daarna op aanhaakte was weer iets waarin hij concludeerde dat mensen slecht zijn.

OG stond eerder vanavond met medeclt te koken, dhr komt de woonkamer inlopen en loopt om het keukenblok heen. Hij zegt "Je staat in de weg", zonder iemand specifiek aan te kijken. Als medeclt opkijkt (die niet in de weg stond) zegt hij "oh nee ik had het niet tegen jou" en lacht hij. OG stond zelf ook niet in de buurt van zijn looproute, onduidelijk wat daar gebeurde.

OG's onderbuikgevoel zegt dat het niet goed gaat, pso gemailld en dit uitgelegd.

2. Dhr is spraakzaam, maar minder wederkerig dan normaal. Dhr zendt vooral. Dhr is negatief gestemd, vooral na aangesproken te worden op zorgen vanuit og, daarvoor ook al vooral negatief over mensen en wat er in de wereld gebeurt.

3. Dhr zegt dat hij na het koffiemoment bij het water gaat zitten naar muziek luisteren. Op de vraag wat voor muziek zegt hij gouden oude. Bij doorvragen naar welk tijdperk dat is voor hem, zegt dhr "vanuit de tijd dat ik nog niet bewust was". Hij komt weer in een stroom terecht waarin hij zegt dat muziek helemaal niet meer goed is, maar zegt dan dat er nooit een moment is geweest dat het goed was en is dan weer slecht te volgen.

algemeen beloop

Beloop Klinisch Doelgericht Rapporteren

Koopman, Tess (Leerling Verpleegkundige) 23-07-2026 09:48:11

observatiepunten en doelen

1. Zijn er veranderingen in psychiatrische toestandsbeeld?
2. Hoe is dhr. in contact? Hoe is zijn stemming?
3. Hoe vult dhr zijn dag in? Is hij naar dagbesteding (ROADS Hoofddorp) geweest? Op woensdag? Hoeft geen OV-kaarten meegegeven te worden.
4. ADL/HDL op orde?
- ?
- ?
- ?
- ?

doelgerichte rapportage

1. Geen bijzonderheden waargenomen. Dhr. is adequaat en vriendelijk in gesprek, dhr. komt ontspannen over.
2. Dhr. geeft aan dat het goed gaat. Dhr. had onthouden dat het vandaag og haar laatste dag is en vroeg hier geïnteresseerd naar.
3. Dhr. vertelt vandaag een afspraak bij de mondhygiënist in Beverwijk te hebben.
4. ADL is op orde.

algemeen beloop

Dhr. heeft medicatie van 8 uur volgens voorschrift ingenomen. Dhr. heeft medicatie van 12:00 uur en 15:00 uur meegekregen.

Beloop Klinisch Doelgericht Rapporteren

Berri, Adil (Verpleegkundige) 23-07-2026 06:30:11

observatiepunten en doelen

1. Zijn er veranderingen in psychiatrische toestandsbeeld?
2. Hoe is dhr. in contact? Hoe is zijn stemming?
3. Hoe vult dhr zijn dag in? Is hij naar dagbesteding (ROADS Hoofddorp) geweest? Op woensdag? Hoeft geen OV-kaarten meegegeven te worden.
4. ADL/HDL op orde?
- ?
- ?
- ?
- ?

doelgerichte rapportage

algemeen beloop

Dhr verbleef gedurende de nacht op zijn appartement, geen contact met dhr gehad.

Voortgang: Gesprek met clt en moeder

Koenders, Jitske (GZ-psycholoog) 06-08-2026 16:25:57

snelkeuze**omschrijving**

Gesprek met clt en moeder

verslag

Moeder vertelt erg geschrokken te zijn van ons bericht aan clt dat we denken dat hij mogelijk beginnend psychotisch is. Ze refereert naar ons telefoongesprek van vorige week waarin we samen een hele andere hypothese hebben besproken voor wat er met Tom aan de hand is. Ze was geschrokken en ook verdrietig omdat ze bang is wat dit doet met het vertrouwen van Tom in zichzelf en denkt dat het ook invloed kan hebben op Tom's vertrouwen in ons.

Clt vraagt om verdere uitleg waarop onze zienswijze gebaseerd is. gepoogd uit te leggen dat dit ook lastig is omdat clt zeker niet enorm psychotisch is en dat dat het moeilijk maakt om concreet gedrag aan te wijzen waarop we dit baseren. De dingen die ik noem zouden ook voor een andere uitleg vatbaar zijn. Maar het feit dat er nog nooit eerder in het verblijf van Tom hier zorgen over hem waren (van verschillende kanten) en de combinatie van dingen die we zien + onze ervaring psychotische klachten maken toch dat we vermoeden dat dit nu aan de hand is. Dat wil niet zeggen dat we het 100% zeker weten en de verklaring van Tom en moeder (er is sprake van herstel naar de oude ik van Tom) helemaal kunnen afwijzen. Het dilemma was: gaan we afwachten tot het mogelijk nog verder uit de hand loopt maar dan is er wellicht wel meer zekerheid of gaan we wel al nu deze gesprekken aan juist om dit erger te voorkomen alleen met wellicht nog minder zekerheid. We hebben voor dit laatste gekozen, uitgesproken dat ik dat goed zorgverlenerschap vind. Maar het feit dat de signalen die we nu oppikken relatief subtiel zijn maakt dat we voor de onderbouwing meer moeten terugvallen op ons onderbuikgevoel en professionele blik. En dat maakt dat een andere mogelijke verklaring daar inderdaad ook naast kan staan. Tom legt ook uit dat hij er 100% van overtuigd is niet psychotisch te zijn en daarom ook moeite te hebben met open te staan voor deze verklaring. Besproken dat dit vroeger wel anders is geweest en dat ik denk dat als wij een tijd geleden onze zorgen hadden uitgesproken Tom daar heel anders op gereageerd en misschien meer open had gestaan voor onze kijk. Tom geeft ook aan dat hij liever niet heeft dat ik aansluit bij het geplande gesprek met de psa maandag. Verder vertelt Tom niet zozeer moeite te hebben met de medicatieverhoging maar vooral met het feit dat er op die manier door ons naar hem gekeken wordt. En dat het evalueren van zijn gedrag bij de medicatie-evaluatiemomenten er voor zorgt dat hij een 'proefperiode'-gevoel krijgt en daarmee meer onder een vergrootglas komt te liggen. Dit voelt als een stap terug met hoe de situatie hiervoor was. Verder geeft hij nog aan zijn dossier van de afgelopen 2 weken op te willen vragen om terug te kunnen lezen wat er precies over hem geregistreerd is qua zorgen die we allemaal over hem hebben, hij hoopt dat hem dat wat inzicht zal geven. Als ik voorstel dat we het dossier ook samen op de computer kunnen bekijken geeft hij aan het liever zelf alvast te kunnen lezen en zich zo voor te kunnen bereiden, ook om op het moment zelf niet te scherp uit de hoek te komen, iets waarvan hij weet dat het een valkuil kan zijn als emoties te hoog oplopen en hij wilt het gesprek constructief houden. Besproken dat dat goed is dat hij dit van zichzelf weet en dat ik dit voor hem ga uitzoeken hoe we dit het beste kunnen doen.

Uitgesproken dat ik ook hoop dat wij ongelijk hebben en dat er niets aan de hand blijkt. Samen met clt uitgesproken dat we hopen ooit de waarheid te achterhalen, deal gemaakt dat als wij ongelijk blijken te hebben dat hij appeltaart van ons krijgt en vice versa.

Een tijdje na de start van het gesprek vraagt Tom toestemming om het gesprek op te nemen en geeft aan dat hij dit nu vaker wil gaan doen om zichzelf te kunnen verdedigen als dit nodig is. Besproken dat ik (en moeder) hiervoor toestemming geven maar wel gevraagd of hij dat wel elke keer opnieuw wilt vragen. Dat wil hij.

Tijdens het gesprek kan cliënt op momenten erg boos en scherp uit de hoek komen, waarin hij ook benoemt boos te zijn. Hij praat dan door mijn uitleg heen, toen hij daarop werd aangesproken en mij vervolgens ook liet uitpraten liep het gesprek beter en vriendelijker. Ondanks dat we het met elkaar oneens blijven over de hypothese waardoor de veranderingen die we zien bij Tom verklaard kunnen worden lukt het wel om elkaars standpunten hierin te horen en te begrijpen en het gesprek goed af te ronden.

Even na het gesprek komt clt nog langs met een stuk appeltaart, vooral om aan te geven dat hij een vervelend gevoel had bij het gesprek, hij vond dat hij wat te scherp is geweest. Besproken dat ik het gebaar erg waardeer. Dit laat ook zien dat clt van zijn kant moeite doet voor het behouden van een goede behandelrelatie wat belangrijk is voor de verdere voortgang.

Voortgang: Gesprek pso

Koenders, Jitske (GZ-psycholoog) 03-08-2026 12:10:17

snelkeuze

omschrijving

Gesprek pso

verslag

- Clt is niet naar lab gegaan vanochtend, wil dat liever niet
- Besproken dat ik een bericht ga geven dat hij niet leuk vind om te horen: ik denk dat hij psychotisch aan het worden is. Er is nooit een 100% garantie, de andere hypothese (dat dit onderdeel is van zijn herstel) is er wat ons betreft ook nog, echter ik denk zoals ik cliënt nu ken en hij zou me vragen wat ik denk dat er aan de hand is dan zou ik zeggen dat ik denk dat hij psychotisch is. Cliënt regaeert in eerste instantie: prima, wat gaan we nu doen? Signaleringsplan, aripiprazol erbij? Zullen we meteen naar de psa lopen? akkoord
- Daarna samen naar Marijke gegaan (zie rapportage Marijke). Waarbij clt een paar keer wisselt tussen zijn eerste houding (ik vertrouw jullie, dus wat zullen we er nu aan gaan doen?) en tussen een meer sceptische benadering (waar baseren jullie dit eigenlijk op? Op basis van 2 gesprekken ga je zulke uitspraken doen?). Voor hem is het belangrijk dat we beide scenario's naast elkaar laten bestaan, dat is prima. Er is ook geen 100% zekerheid in deze situaties en benadrukt dat we er ook nog op tijd bij zijn wat ons betreft.
- Clt vraagt of er nog andere dingen zijn die hij zelf kan doen mbt niet-psychotisch worden. Goed dag-nachtritme, geen middelengebruik, goed blijven eten en drinken en vooral doorgaan met activiteiten besproken. Verder noemde clt nog sinds kort 3 a 4 dagen in de week s avonds bij het water 1 of 2 biertjes te drinken, ter ontspanning volgens clt. Dit is ook redelijk nieuw gedrag. Waarbij in het verleden psychotische ontregeling ook samen ging met middelengebruik. Dit wel besproken, clt vind dit echter geen prioriteit om dit nu aan te passen. Het is ook niet zo dat je er direct meer psychotisch van wordt, maar het past wel bij het patroon van vroeger waarbij clt weer langzaam meer middelen gaat gebruiken. Clt op deze parallel gewezen.
- Aripiprazol naar 5mg per dag, deze verhoging direct met clt gaan halen bij vpk. Clt neemt deze ter plekke in.
- Daarna nog even gaan zitten met clt om in te checken. Clt vindt het een vervelend bericht, het roept ook weer zorgen op (kan ik straks wel afstand doen van de GGZ? Hoe zal dit in de toekomst gaan?). Begrijpelijk. Gevraagd of als zijn moeder hier komt donderdag hij het prettig vindt om nog even met z'n 3en hierover te spreken. Van clt zelf hoeft het niet, maar hij zal wel bespreken met zijn moeder dat de medicatie is opgehoogd, mocht zij er toch behoefte aan hebben laat hij het weten. Voor maandag 10/8 om 10u medicatie-evaluatie met psa MJJ erbij
Dinsdag 11/8 om 11u met JK signaleringsplan-afpraak

Voortgang: Medicatie

Josephus Jitta, Marijke (Psychiater) 03-08-2026 11:24:37

snelkeuze

omschrijving

Medicatie

verslag

Eerste tekenen van psychose. Afgesproken om aripiprazol op te hogen van 2,5 naar 5 mg per dag. Voor nu de dexamfetamine gelijk houden. Volgende week opnieuw overleg.

Voortgang: Gesprek pso

Koenders, Jitske (GZ-psycholoog) 31-07-2026 12:09:35

snelkeuze

omschrijving

Gesprek pso

verslag

Clt vertelt dat het goed gaat. Hij heeft geen pitch voorbereid, september duurt nog te lang. Tzt verder naar kijken.
Clt is veel meer abstract in zijn denken en praten dan ik van hem gewend ben. Hij maakt soms moeilijk te volgen connecties en ik moet echt mijn best doen om hem te begrijpen. Dit ook met cliënt besproken, die vertelt dat hij ook wel minder abstract kan praten maar denkt dat hij dat met mij wel kan doen. Verder blijft hij volhouden dat dit al zijn hele leven zo is geweest en dat hij altijd een wat vreemde eend in de bijt is geweest. Besproken dat ik merk dat ik er aan moet wennen en echt mijn best moet doen om hem te volgen. Besproken dat dit dan wel meer in zijn leven een probleem moet zijn geweest, dat erkent clt ook. Besproken dat een verandering in communicatiestijl en vooral in het veel breder denken en daarmee vager taalgebruik bij veel cliënten een teken kan zijn van psychose en dat het minder goed gaat. Kennelijk is dat bij clt niet zo volgens moeder en clt. Besproken dat we

samen dan een nieuw signaleringsplan moeten opstellen als dit inderdaad het nieuwe normaal is voor clt. De grote uitdaging wordt dan het verschil gaan zien tussen de brede, filosofische gedachten die clt nu al heeft en het ontstaan van de wanen.

Clt vertelt over waar hij mee bezig is: nieuw soort AI ontwikkelen, reflecteren op de invloed van reguliere AI op de mensheid, de technische kant van het milieuprobleem. Vooral als hij hierover praat blijft hij er vaag en algemeen. Vertelt dat hij een product aan het ontwikkelen is waarvoor hij spullen heeft besteld maar kan/wil niet aangeven wat dit dan precies is.

Later vertelt clt dat hij het jaarlijkse lab dat gepland staat voor ma 3-8 liever niet wil doen, maar hij wil ook niet zo ver gaan om te weigeren. Hij wilt niet in een situatie terechtkomen waar hij zzz eventueel moet verdedigen tegen eventuele uitkomsten van een onderzoek, bijvoorbeeld dat hij een te hoog cholesterol heeft en dus zijn levensstijl zou moeten veranderen. Clt is hier echter al mee bezig, dus wat is het probleem? Dat blijft een beetje onduidelijk. Uiteindelijk zegt clt dat het fijn is het er over te hebben gehad en dat hij het gewoon gaat doen maandag.

Observaties: clt is moeilijker te volgen dan maandag. Ook vertelt clt over dat hij een nieuw soort AI heeft uitgevonden en de computer wilt verslaan. Clt is natuurlijk erg kundig maar de vraag of dit ook niet toch raakt aan grootsheid komt wel bij me op.

C/

Is dit een man met een zeer hooggegaafde/andere/abstracte stijl van denken als uitgangspunt, welke nu weer terugkomt na jaren van psychose en medicatie? (Standpunt van moeder en clt). Echter dan voelt de overgang wel groot. Aan de andere kant is dat ook passend bij clt, hij lijkt vaker ineens een 'knop om te zetten', ook met anderen veranderingen. Of kijken we toch wel naar een beginnende psychotische ontregeling? Ik denk dat we dit niet kunnen uitsluiten noch bevestigen op dit moment.

B/

Met clt in contact blijven en blijven monitoren, bij veranderingen of toenemende zorgen wederom contact leggen met clt en moeder hierover

Voortgang: Gesprek pso

Koenders, Jitske (GZ-psycholoog) 27-07-2026 14:38:33

snelkeuze

omschrijving

Gesprek pso

verslag

Met cliënt besproken dat collega's veel veranderingen bij hem zien de afgelopen tijd, en dat dat bij mij de vraag oproept wat het is wat collega's zien en of we ons daar zorgen over moeten maken. Korte samenvatting van enkele punten gegeven die ik vaker terug hoor komen, maar ook uitgesproken dat dit niet het hele verhaal is: het gaat ook meer over een gevoel, clt wordt anders ervaren in het contact. Waar ik hiervoor nooit opmerkingen of zorgen over clt kreeg, krijg ik dat nu al enkele weken. Goed om samen te onderzoeken.

Clt zegt ook dat dat wel klopt, er zijn veel veranderingen in zijn leven de afgelopen tijd dus daar zijn we het over eens. Hij zegt dit zelf juist meer te zien als 1. Een nieuwe fase van herstel, meer gericht op zelfreflectie, maar ook op de toekomst. Clt begint na te denken over of hij eventueel kinderen zou willen. Maar op welke wereld komen die dan te staan? Hij wilt niet uit egoïsme een kind nemen en er wel achter kunnen staan. Maar wat zijn dan zijn normen en waarden? Clt zegt hier veel mee bezig te zijn. Iets wat hij lang niet meer heeft gedaan. 2. Zijn emoties beginnen meer terug te komen na een lange periode van afwezigheid. Hijzelf merkt juist dat daardoor weer de oude Tom omhoog komt, met zowel de positieve kanten als ook de negatieve kanten. Want voordat hij last kreeg van psychoses had hij ook niet altijd de meeste stabiele emotie-huishouding, daar kon hij vaak paniekerig en angstig zijn bijvoorbeeld. Hij merkt dat emoties (zowel goed als slecht) weer terugkomen en dat hij weer meer om moet leren gaan met deze opude kanten van zichzelf, die hij zo lang kwijt is geweest.

Besproken dat dit voor ons soms moeilijk te duiden is: wij kennen die oude Tom niet, alleen de (volgens Tom) 'afgevlakte versie' van Tom. Tom's moeder kent deze beide kanten wel. Tom stelt voor haar direct te bellen ("dan weet je zeker dat ik haar niet geïnstrueerd heb").

Moeder samen gebeld op luidspreker, uitleg waarom we bellen en wat de vraag is.

Moeder geeft aan deze verandering ook duidelijk te zien, maar hier zelf vooral naar te kijken dat de oude trekjes van Tom juist weer terugkomen. Moeder noemt bijvoorbeeld ook hem soms niet helemaal te kunnen volgen (iets wat onze collega's ook opmerkten) en dat ze dit herkent van vroeger, dan is Tom al 3 gedachtestappen verder dan zij. Hij praat veel sneller en drukker en denkt ook weer sneller. Zo was het altijd al, totdat hij ziek werd. Ook noemt ze dat Tom ook heel 'duidelijk en scherp' kan zijn in zijn communicatie, waarbij hij ook soms wat geïrriteerd over kan komen als hem iets niet zint. Dit was inderdaad ook iets dat collega's opmerkten. Volgens moeder is dat ook altijd al zo geweest vroeger.

Zo kennen wij Tom helemaal niet, maar dit past kennelijk wel bij hoe Tom is als persoon. Besproken dat dit goede behulpzame voorbeelden zijn.

Moeder zegt zich helemaal geen zorgen te maken, ze begrijpt wel waar onze vragen vandaan komen, zij

moet ook even wennen aan de nieuwe situatie, maar hoopt vooral dat Tom zich hier niet verder door tegengehouden voelt om zichzelf te uitten richting ons. Het is jammer dat hij juist steeds meer zichzelf wordt en daar soms 'afgestraft' voor lijkt te worden. Dat levert hem ook frustratie op. moeder zegt veel vertrouwen te hebben in Tom dat hij aan de belt trekt als het niet goed gaat. Ze merkt dat hij open en eerlijk is met haar, ook als het even minder goed gaat. Tom spreekt uit dat hij het ook echt aangeeft zeker aan mij en moeder als het minder goed gaat. Nog met Tom een specifiek voorbeeld met een collega nabesproken, waarbij Tom ook merkt dat hij soms niet over dingen wilt praten (uit de angst dat het verkeerd geïnterpreteerd wordt) en dan kortaf reageert. Dat is een nieuwe ontwikkeling uit een recent ontstane angst. Dat merken collega's natuurlijk ook en die vragen zich dan af wat er aan de hand is, dat is logisch. Bij nader inzien begrijpt Tom dat ook wel dat zijn wat afhoudende houding ook dit effect kan hebben op anderen en daarmee zelf deze dynamiek versterkt. Verder geeft clt ook aan dat hij nu juist durft te laten zien dat hij afgeleid is, vroeger zou hij meer hebben meegeknikt en net gedaan hebben alsof hij het volgt. Nu is hij minder sociaal wenselijk op dat vlak. Het is dus niet zo dat hij meer is afgeleid dan voorheen, maar hij verbergt het minder. Wat als laatste nog meespeelt is dat veranderingen bij clt in het verleden altijd van 0 naar 100 in korte tijd zijn gegaan. Waarbij andere personen veranderingen geleidelijker zijn is dat bij Tom nooit zo geweest, ook vroeger niet. besproken dat een grote verandering soms voor ons wel wat alarmlichten kan geven, dat snapt Tom ook. Ook besproken dat we niet altijd er op kunnen vertrouwen dat iemand zelf komt als het niet goed gaat, omdat mensen dat soms zelf niet meer doorhebben. Tom komt dan spontaan met wat voorbeelden waar voor hem de grens ligt met wanneer het niet meer goed gaat en wanneer hij aan de bel zou trekken.

C/

Al met al lijkt er dus inderdaad sprake van een verandering, maar voor zover ik dat nu kan inschatten is deze passend bij Tom die steeds meer de oude (en ook iets meer imperfecte) versie van zichzelf wordt.

Afgesproken dat we er gewoon open met elkaar en met zijn moeder over in gesprek blijven.

Groep MDO / indirect: Ochtend 27-7-2026

Koenders, Jitske (GZ-psycholoog) 27-07-2026 09:07:49

Algemene Groepsrapportage

snelkeuze

omschrijving

Ochtend 27-7-2026

Algemene groepsrapportage

Ochtend 27-7-2026

Rapportage cliënt

Rapportage client

Collega's vinden clt anders dan voorheen, Clt reageert geïrriteerd als dit met hem wordt besproken. Daginvulling van clt ziet er anders uit: gestopt met IT-projecten en twijfelt over dagbesteding. Sneller afgeleid, sneller geïrriteerd. Reactie anders: voorheen zorgen over psychotisch worden, en nu als collega's hem ergens op aanspreken is hij juist in de weerstand ipv zich hier zorgen over te maken.

Lastige is dat er geen hele concrete aanwijzingen zijn voor psychose zoals wanen of hallucinaties, maar wel bij meerdere collega's een gevoel dat er duidelijk nu iets anders is in het contact met clt en de communicatie. Het is moeilijk vast te pinnen op hele concrete dingen, alle losse veranderingen op zichzelf zijn niet heel bijzonder of zorgelijk, het is meer het veranderende beeld in het geheel

B/

JK gaat het vandaag met clt wederom bespreken